FICHE TLC Anesthésie

Situation clinique

Actuellement plus de 12 millions d'actes d'anesthésie ont lieu en France. La Consultation de Pré Anesthésie (CPA) est une obligation réglementaire depuis le décret sécurité anesthésique du 5 décembre 1994 et doit être réalisée au moins 48 heures avant toute intervention programmée sous anesthésie locorégionale ou générale. Cette consultation concerne les interventions chirurgicales, accouchements et examens nécessitant une prise en charge analgésique / anesthésique.

Une téléconsultation peut être réalisée dans le cadre de la CPA. Une téléconsultation avec un médecin anesthésiste peut également être réalisée, en complément, en pré ou postopératoire, accouchement pour un suivi particulier (analgésie, suivi d'évènements indésirables (CPBDM..) ….).

A. Points clés du déroulement d'une téléconsultation pré anesthésique

La téléconsultation pré anesthésique doit répondre **aux mêmes impératifs** qu'en consultation présentielle (référence HAS indicateurs de sécurité et qualité des soins).

1. **Evaluer les risques**
   - Liés au patient et à ses ATCD de santé.

Ceci est réalisable avant la TLC grâce à la récupération des éléments anamnestiques, des traitements, des comptes rendu des spécialistes rencontrés et du questionnaire de santé. Ces éléments pourront être déposés en amont dans un espace sécurisé (HDS*) accessible au patient et au médecin.

   - Liés à la prise en charge : Évaluation des abords veineux, de l'accès aux voies aériennes et au rachis.

L'évaluation des critères physiques peut être modifiée / adaptée dans le cadre d'une évaluation à distance : inspection du pharynx devant l'écran avec torche du téléphone, évaluation de l'ouverture de bouche et de la circonférence du cou avec les doigts du patient, évaluation de la souplesse du patient par distance main-sol, autopalpation du rachis (cf. fiche spécifique). Des captures d'écran peuvent être réalisées pour enrichir le dossier d'anesthésie.

2. **Examen physique**

   L'examen physique peut être modifié / adapté dans le cadre d'une évaluation à distance comme décrit ci-dessus. Deux points particuliers :
   - La connaissance de la pression artérielle de base.

La mesure rapportée en consultation pourra être celle habituellement mesurée par le patient chez son médecin ou par le recours à un appareil d'automesure. En cas d'absence de cette donnée, elle sera mesurée en préopératoire.

- L'auscultation cardio-respiratoire est rarement possible en téléconsultation (nécessité d'outils connectés, réalisable lors de téléconsultation accompagnée par un professionnel de santé).

La visite pré-anesthésique (VPA) est d'autant plus importante qu'elle va permettre de compléter l'examen clinique réalisé lors de la TLC. La VPA peut être organisée « en miroir » sous forme de liste rapportant les éléments à contrôler précisément lors de la rencontre avec le patient.

À tout moment, ***une téléconsultation peut être interrompue à la demande du praticien ou du patient et conduire à une convocation en présentiel.***

3. Informer le patient, définir la prise en charge et lui remettre les documents de son parcours

Comme en présentiel, un temps d'information et d'échange entre le patient et le médecin doit être réalisé.

En fin de téléconsultation le patient reçoit les documents relevant de sa prise en charge (ordonnances, lettre d'adressage vers d'autres spécialistes, synthèse du parcours….). Ces éléments peuvent être envoyés sur un espace sécurisé (HDS) ou par voie postale.

B Points clefs Organisationnels

1. Sur le plan technique et au niveau du cabinet de consultation

L'équipement informatique minimal comprend un ordinateur avec système audio et visio (webcam). La possibilité d'un second écran déporté pour accès aisé au logiciel de TLC ainsi qu'au logiciel métier (anesthésie) voire au DPI est conseillé.

La prise de RDV peut demander une organisation spécifique avec le secrétariat (problème de la double saisie dans les outils de RDV de l'établissement et de la plateforme de TLC).

La durée de la consultation est au moins aussi longue qu'en présentiel, une économie de temps n'est pas à prévoir. L'anesthésiste-réanimateur doit être présent dans des locaux assurant le respect de la confidentialité des échanges et donc la préservation du secret médical.

2. Préparation de la TLC

L'information du patient ainsi que son consentement à cette modalité de rendez-vous doivent être obtenus.

Un certain nombre de supports peuvent être crées pour accompagner le patient :

- Une information spécifique sur cette modalité de consultation (cf fiche spécifique). Pour la télé CPA obstétricale une page internet dédiée a été créée en lien avec le CARO (www.preanesthesie.fr).
- Des documents numériques de parcours de soins (à l'instar des documents papiers remis lors de consultations présentielles).

Le patient peut être accompagné dans la TLC par un professionnel de santé (IDE, pharmacien) qui sera rémunéré pour cet acte (Avenants 6 et 15 de la convention collective de l'assurance maladie) ou par un aidant familial.

Le patient doit également être dans un environnement calme, dans un espace lui permettant d'échanger des informations médicales en toute confidentialité.

3. Le choix d'orientation vers la téléconsultation doit être réfléchi en équipe

Les secteurs d'anesthésie-réanimation peuvent définir, au sein de leur organisation, les critères de sélection des patients vus en téléconsultation sachant qu'il existe à l'heure actuelle peu de recommandations. La SFAR en 2017, indiquait qu'il s'agit probablement préférentiellement de patients devant bénéficier d'une intervention à risque mineur ou intermédiaire et/ou de consultations itératives. La TLC est également adaptée aux patients qui sont dans des environnements pouvant permettre une préparation et un accompagnement médical pendant la TLC, comme cela est le cas dans les EHPAD ou les établissements pénitentiaires.